PROTOCOLLO 94

Trisma dopo trattamenti oncologici del distretto testa collo

Recuperare l'apertura in collaborazione con l'équipe oncologica

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Trisma post oncologico	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Riduzione dell'apertura dopo radioterapia o chirurgia
- ✓ Difficoltà nell'igiene orale e nell'alimentazione
- ✓ Paziente inviato dall'équipe oncologica

Controindicazioni e precauzioni

- ! Assenza di autorizzazione dell'équipe oncologica
- ! Lesioni dei tessuti irradiati
- ! Infezioni del cavo orale
- ! Segni di recidiva

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Autorizzazione

Accordo con l'équipe oncologica su tempi e limiti.

2



FASE 2

Esercizio frequente

Aperture attive e allungamenti brevi più volte al giorno.

3



FASE 3

Dispositivi

Uso di dispositivi di apertura se prescritti.

4



FASE 4

Monitoraggio

Misura dell'apertura ogni settimana.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Esercizio	5 volte al giorno
Allungamento	30 secondi, 5 ripetizioni
Misura	settimanale

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La costanza quotidiana è determinante
- ✓ Collaborazione continua con l'équipe
- ✓ Attenzione ai tessuti irradiati

Errori da evitare

- ! Forzare tessuti irradiati
- ! Trattare senza autorizzazione
- ! Ignorare segni di recidiva o infezione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Allungamento frequente	Apertura assistita con abbassalingua	5 x 30 secondi, 5 volte al giorno

! **Nota clinica.** Nuovi sintomi, tumefazioni o peggioramento rapido vanno segnalati subito all'équipe oncologica.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.